

Wycofanie zachowań zapewniających

„Czy widać?” — pytanie, które krótkoterminowo łagodzi lęk, długoterminowo utrzymuje BDD. Wycofanie tych zachowań jest jednym z najtrudniejszych, ale najskuteczniejszych kroków terapii. Bez tego ERP nie działa.

CZAS: 15 min — przeczytanie Z partnerem / rodziną **ŹRÓDŁO:** Wilhelm (2013); Salkovskis (1991)

JAK UŻYWAĆ

Zachowania zapewniające (ang. *reassurance seeking*) — w BDD: pytania o wygląd („czy widać?”, „jest źle widoczne?”, „czy ten makijaż zakrywa?”), prośby o ocenę, prowadzenie bliskich do luster, wysyłanie zdjęć ze prośbą o opinię, konsultacje u dermatologów / chirurgów „tylko żeby się dowiedzieć”. Każde z tych zachowań: **krótkoterminowo** obniża dystres (5 minut — kilka godzin), **długoterminowo** utrzymuje BDD (zapewnienie „wygasa”, potrzeba kolejnego rośnię). Mechanizm taki sam jak w OCD i lęku uogólnionym. Wycofanie jest jednym z trzech najtrudniejszych kroków terapii (obok ekspozycji i mirror retraining) — bo działa *przeciw natychmiastowej uldze*. Ale jest *warunkiem* wyjścia z BDD.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Salkovskis (1991) opisał *poszukiwanie zapewnień* jako klasyczne zachowanie zapobiegające reakcji w OCD. Wilhelm (2013) zaadaptowała tę pracę do BDD. Mechanizm: **1)** pojawia się lęk o wygląd → **2)** pytasz partnera „czy widać?” → **3)** partner mówi „nie widać” → **4)** krótkoterminowa ulga → **5)** mózg uczy się: „tylko zapewnienie chroni” → **6)** potrzeba kolejnego pytania, częściej i intensywniej. *Tolerancja* rośnie, jak w uzależnieniu. Wilhelm: „pacjenci pytają partnerów 30-100 razy dziennie. Partnerzy odpowiadają — wzmacniając cykl. Wycofanie zapewnień jest podobne do detoxu od substancji: pierwsze 2 tygodnie najgorsze, potem stopniowo lepiej”. Skuteczność: 4-6 tygodni systematycznego wycofywania prowadzi u 70% pacjentów do *spontanicznego zmniejszenia* potrzeby pytania. Bez tego ERP nie działa.

01 = Pięć form zachowań zapewniających

1 · PYTANIE WPROST

„Czy widać pryszcz na czole?”, „Wyglądam dziś dobrze?”, „Czy ten makijaż dobrze zakrywa?”. Partner, mama, przyjaciel.

2 · PROWADZENIE DO LUSTRA

„Chodź ze mną do łazienki — zobacz”. Wspólne sprawdzanie. Partner staje się „lustrzem ratunkowym”.

3 · WYSYŁANIE ZDJĘĆ

„Czy ten kąt jest OK?”. Wysyłasz selfie ze prośbą o ocenę. Partner online dostaje dziennie 5-20 wiadomości tego typu.

4 · KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

„Tylko się dowiem od chirurga”. Konsultacje u dermatologów, chirurgów plastycznych. Każda to rytuał zapewnienia — pogarsza BDD.

5 · POŚREDNIE PYTANIA

„Czy ludzie na imprezie się gapili?”, „Jak na zdjęciach z wakacji wyglądam?”. Pytania o reakcje innych — to też zapewnienia.

02 ● Trzyfazowy plan wycofania

Faza 1 (tygodnie 1-2): Świadomość. Monitorujesz, ile razy dziennie prosisz o zapewnienie. *Nie zmieniasz* jeszcze nic — tylko liczysz. Wspólnie z partnerem. Często pacjenci są zaskoczeni — 30, 50, 100 razy dziennie.

Faza 2 (tygodnie 3-4): Częściowe wycofanie. Partner zaczyna odpowiadać uzgodnioną formułą: „Pamiętamy oboje, że to jest pytanie BDD. Nie odpowiem, ale jestem z Tobą”. Krótko, ciepło, konsekwentnie. Z Twoją zgodą — to wasza wspólna decyzja, nie kara.

Faza 3 (tygodnie 5+): Pełne wycofanie. Partner nie odpowiada na żadne pytania o wygląd. Również na pośrednie. Również w wiadomościach. Również do innych członków rodziny — informujecie ich.

KRÓTKIE, CIEPŁE

„Wiemy oboje, że odpowiedź nie pomoże. Kocham Cię.”

„To pytanie BDD — pamiętamy, że nie odpowiadamy.”

„Jestem z Tobą, ale na to nie odpowiem.”

PRZEKIEROWANIE

„Może zrób krótką sesję mirror retraining?”

„Pamiętaj, że mamy nie odpowiadać — co byś teraz zrobiła zamiast pytać?”

„Może wyjdziemy na spacer?”

✗ **Czego się spodziewać — krzywa odzwyczajania**

Tydzień 1-2: potrzeba pytania *wzrasta* — to klasyczna reakcja na blokadę. Frustracja, gniew na partnera, „nie rozumie”. Jest *najtrudniej* w drugim tygodniu. Wytrwaj — to próg.

Tydzień 3-4: potrzeba pytania nadal pojawia się, ale *częściej rezygnujesz sam/-a*. Pierwsze chwile: „*chciałam zapytać, ale przeszło*”. To moment przełomowy.

Tydzień 5-8: potrzeba pytania *znacząco maleje*. Pojawia się 2-5 razy dziennie zamiast 30-100. Łatwiej z nią pracować.

Tydzień 9-12: w spokojnych dniach potrzeba *prawie nie pojawia się*. W stresie wraca — ale już nie dominuje. Mózg się przeuczył.

● **Wskazówki dla pacjenta****WSPÓLNA UMOWA**

Z partnerem — najlepiej w obecności terapeuty. *Wasza wspólna decyzja*, nie nagłe wycofanie. Pisemne zasady pomagają.

BEZ GNIEWU

Brak odpowiedzi partnera nie jest *karą*. To uzgodniona *terapia*. Pamiętaj o tym, gdy poczujesz gniew.

PLAN ZASTĘPCZY

Gdy pojawia się potrzeba pytania: mirror retraining 5 min, oddech 4-7-8, spacer 10 min. Coś, co przekieruje uwagę.

BEZ SPRAWDZANIA POŚREDNIEGO

Nie czytaj wiadomości partnera „*czy zgadza się ze mną*”. Nie szukaj sygnałów niewerbalnych. Zapewnienie = każda forma.

Klucz: Wilhelm (2013): „*partner, który przestaje odpowiadać na pytania o wygląd, daje pacjentowi największy prezent. To kontrintuicyjne — wygląda jak odrzucenie. W rzeczywistości jest jedynym sposobem, by pacjent nauczył się tolerować lęk bez zewnętrznego ratunku. Bez tej nauki — wyjście z BDD jest niemożliwe*”. Wycofanie zapewnień jest trudne — i jest warunkiem zdrowienia.